



**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
UNIDAD DE POSGRADO**

PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO

**INICIO DE RELACIONES SEXUALES Y NÚMERO DE PAREJAS
SEXUALES ASOCIADO AL GENOTIPO DEL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO, DIRIS LIMA CENTRO, 2023**

PARA OPTAR

**EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA CON
MENCIÓN EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER GINECOLÓGICO**

PRESENTADO POR:

SANDRA MARIELA CHURA BORDA

ASESOR:

MG. MARÍA DEL CARMEN NUÑEZ TERÁN

LIMA, PERÚ

2023

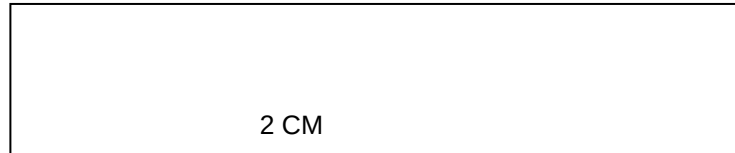
ÍNDICE

	Página
ÍNDICE	2
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
1.1 Descripción de la situación problemática.....	4
1.2 Formulación del problema	7
1.3 Objetivos de la investigación	7
Objetivos específicos.....	8
1.4 Justificación de la investigación.....	9
1.4.1 Importancia de la investigación	9
1.4.2 Viabilidad del estudio.....	10
1.5 Limitaciones de estudio	12
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	13
2.1 Antecedentes de la investigación	13
2.2 Bases Teóricas.....	16
2.2.1 Cuello uterino	16
2.2.2 Cáncer de cuello uterino.....	16
2.2.3 Biología del cáncer de cuello uterino y progresión	17
2.2.4 Factores de riesgo del cáncer de cuello uterino	19
2.3 Definición de términos básicos	27
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES	30
3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas	30
3.2 Variables y definición operacional	31
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA.....	32
4.1 Diseño metodológico	32
4.2 Diseño muestral.....	32
4.3 Técnica de recolección de datos	33
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información.....	33

4.5 Aspectos éticos	34
CRONOGRAMA.....	35
PRESUPUESTO	36
BIBLIOGRAFIA.....	37
ANEXO A.....	44
ANEXO B.....	45
ANEXO C	46



CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



1.1 Descripción de la situación problemática

El cáncer de cuello uterino (CCU), es una enfermedad prevenible y curable, si se detecta de forma temprana y se maneja de forma efectiva. Sin embargo, es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. En este contexto, en agosto del 2020, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la “Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema mundial de salud pública y sus objetivos y metas conexos para el periodo 2020-2030”, cuyos pilares se centran en: la prevención a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano; la detección y el tratamiento de lesiones precancerosas; y el tratamiento del CCU invasivo, incluido el acceso a cuidados paliativos.¹

En el Perú, según los datos publicado por Globocan 2020, el número de casos nuevos de CCU es de 4270 (11.5%), ocupando el segundo lugar de cáncer en mujeres, provocando 2288 muertes (6.5%), donde cada día, 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de CCU y 6 mujeres fallecen por esta enfermedad.²

En el 2017, el Ministerio de Salud aprueba mediante Resolución Ministerial N° 440-2017/MINSA, el Documento Técnico: “Plan Nacional para la Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino”, cuya finalidad es reducir la morbi mortalidad por cáncer de cuello uterino en el Perú. Las necesidades de los servicios para la

atención integral del CCU a nivel nacional se encuentran determinadas según nivel de atención y en el marco de las definiciones operacionales del Programa Presupuestal 024 “Prevención y control del cáncer”.³

En el 2020 el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 1003-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer (2020-2024)”, con la finalidad de contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad por cáncer en el Perú, mediante acciones estratégicas con equidad, y enfocadas en la promoción de la salud, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer. Cabe mencionar que en su objetivo específico N° 2 plantea incrementar la capacidad operativa y de calidad de los servicios de salud para el cuidado integral del cáncer, teniendo como acción estratégica el acceso oportuno al tamizaje del cáncer de cuello uterino y mama, así como el manejo de lesiones premalignas, en el caso de cuello uterino contempla el tamizaje a través de la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA), con pruebas moleculares para detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) y Papanicolaou, además considera el manejo de lesiones premalignas con terapia ablativa y excisional.⁴

En el 2021, el gobierno peruano promulgó la Ley N° 31336, Ley Nacional del Cáncer, cuyo objetivo es garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan. Cabe resaltar que en su segunda disposición complementaria señala al CCU como necesidad pública y de interés nacional, dando énfasis a la organización y ejecución de acciones para la prevención, promoción, control y

vigilancia del cáncer de cuello uterino. Desde el 2022, mediante Decreto Supremo N° 004-2022-SA, aprueba el Reglamento de la Ley N°31336, Ley Nacional del Cáncer, con el fin de establecer las disposiciones para la implementación de la Ley de esta manera se les garantizará una atención oportuna y de calidad. En este contexto se aprobó en el Decreto Supremo N° 189-2022-EF, que autoriza la transferencia de partidas a favor del Ministerio de Salud en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 en el producto persona atendida con lesiones premalignas de cuello uterino y sus actividades de atención con ablación o escisión con la finalidad de dar tratamiento preventivo y oportuno, y así contribuir con la disminución de la incidencia del CCU en nuestro país.⁵

Según la revisión del Instituto Nacional de Salud, concluyo que el CCU sigue siendo una importante causa de muerte en las mujeres de países en desarrollo, donde el tamizaje primario con citología cervical no ha logrado reducir la prevalencia de las fases avanzadas de la enfermedad. En este contexto, la detección molecular del VPH ha demostrado ser una prueba más sensible que la citología cervical, y a la vez menos específico.⁶

A partir del 2021, el Ministerio de Salud ha implementado la Detección Molecular del Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo (VPH-AR), iniciándose en Lima Metropolitana y en las regiones de Loreto y Junín, de esta manera se viene implementado en las demás regiones de manera gradual. Además, se ha instalado brigadas de manejo de lesiones premalignas a través de terapias ablativas en el nivel de atención primaria en Lima Metropolitana.

En el contexto actual, la población femenina inicia su actividad sexual cada vez más precoz en todo el mundo, siendo los adolescentes, quienes están expuestos a infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas, la infección por el VPH ocupa un lugar significativo, considerándolo como factor fundamental en el desarrollo de CCU.⁷ Sin embargo, la sola presencia de la infección viral no es suficiente para que ocurra la transformación maligna, para lo cual se hace necesario la coexistencia del VPH-AR con otros factores, tanto del virus como del hospedero, que contribuyan al desarrollo de este tipo de CCU.⁸

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales en mujeres con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023?

1.3 Objetivos de la investigación

Determinar la asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales en mujeres con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.

Objetivos específicos

- Identificar los genotipos del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo presentes en mujeres con resultado positivo, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.
- Identificar las edades de inicio de relaciones sexuales en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.
- Identificar el número de parejas sexuales en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.
- Determinar la asociación entre las edades de inicio de relaciones sexuales y el genotipo identificado en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.
- Determinar la asociación entre el número de parejas sexuales y el genotipo identificado en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.
- Identificar las edades de las mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el

Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.

- Identificar el grado de instrucción de las mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea la “Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema mundial de salud pública y sus objetivos y metas conexos para el periodo 2020-2030”, en todos los estados miembros, dado que es urgente actuar para ampliar la aplicación de medidas costo-efectivas de eficacia demostrada destinadas a conseguir eliminar el CCU como problema mundial de salud pública, tales como: la vacunación contra los papilomas virus humanos, el cribado y el tratamiento de las lesiones precancerosas, la detección temprana y el tratamiento inmediato de los cánceres invasivos en sus fases iniciales, y los cuidados paliativos, para lo cual es necesario determinación política y una mayor cooperación y apoyo internacionales para que el acceso sea equitativo, así como estrategias para la movilización de recursos.¹

Considerando de importancia adoptar una estrategia integral e interprogramática (salud sexual y reproductiva, salud en adolescentes, inmunización y control del

cáncer cervicouterino). El CCU es una enfermedad con una larga historia natural por lo que ofrece múltiples oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer mediante estrategias efectivas de prevención primaria y secundaria junto a un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de los casos, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.⁹

El tamizaje a través de la Detección Molecular del VPH-AR representa un gran avance en la prevención secundaria en nuestro país. Es por ello que la presente investigación analizará los factores de riesgo de CCU, tales como el inicio de relaciones sexuales y el número de pareja sexuales asociados a la Detección Molecular del VPH-AR en mujeres con resultado positivo, con la finalidad de evidenciar la asociación de ambas variables, con miras de fortalecer las estrategias de tamizaje con la educación sexual, que posibiliten conductas sexuales responsables que conlleven al autocuidado de la salud. En ese sentido, estos resultados permiten sustentar la importancia de la prevención del cáncer de cuello uterino a través de actividades de educación y comunicación, enfocados en los factores de riesgo modificables con miras a fortalecer las estrategias de prevención primaria y secundaria del CCU a nivel nacional. Resaltado la importancia de mejorar la calidad de los servicios de consejería y las actividades extramurales en la comunidad.

1.4.2 Viabilidad del estudio

La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, cuenta con la Unidad Funcional de Docencia e Investigación, que evalúa y aprueba proyectos de

investigación, para lo cual se requiere de dicho proyecto aprobado por la Universidad que respalde al investigador, con ello se inicia la gestión de los permisos correspondientes.

Se cuenta con disponibilidad de tiempo para la realización de dicha investigación.

La investigación se llevaría a cabo en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena perteneciente a la DIRIS Lima Centro. Cabe mencionar que desde diciembre del 2021 se ha implementado los tamizajes con la Detección Molecular del VPH en los establecimientos de salud que corresponden a su jurisdicción. Como parte del plan de intervención se ha instalado brigadas de manejo de lesiones premalignas de cuello uterino. En la actualidad se encuentran instaladas 2 brigadas en establecimientos de salud con ubicación estratégica, los cuales son: Centro de Salud Materno Infantil Magdalena y el Centro de Salud Chacarilla de Otero. Estas brigadas realizan el manejo de casos positivos de Prueba Molecular del VPH de alto riesgo, papanicolaou e Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA). Para el presente estudio se utilizará información correspondiente a la Brigada del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena.

Durante el año 2023, la Brigada del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena atendió a pacientes con resultado positivo a la Prueba Molecular del VPH de alto riesgo, correspondiente a la Red Integrada de Salud (RIS) 1, 2, 3 y 4.

El estudio será financiado en su totalidad por la investigadora, la cual tendrá todas las medidas de bioseguridad para la realización del estudio. Los conocimientos corresponden a la revisión bibliográfica de fuentes confiables recolectadas.

1.5 Limitaciones de estudio

- Datos incompletos en las historias clínicas.
- Mujeres mayores de 18 años de edad.
- Accesibilidad en el proceso de toma de información de historia clínica.
- Edad del paciente, paciente que no se encuentren en el rango de edad de 30 a 49 años.
- Información incompleta en la base de datos digital.
- Acceso restringido a determinada información en el servidor de plataforma del sistema de registro de pruebas moleculares del VPH AR.
- Usuaris registradas en la brigada de manejo de lesiones precancerosas de CCU con otro tamizaje positivo diferente a la Prueba Molecular.

5CM

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2 CM

2.1 Antecedentes de la investigación

Luego de haber revisado algunos antecedentes se han encontrado algunos estudios relacionados. Así tenemos que:

Salazar Torres Z., Heredia Cortez J., Zhingre Suárez A., Cárdenas Heredia F., en el 2020 publicaron el artículo “Virus del papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de Ecuador.” Este fue un estudio analítico, de corte transversal; con una muestra de registros clínicos de 109 pacientes encuestadas. Los resultados observados fueron de 28,4% de los casos de pacientes con VPH AR, de estas se identificó como el genotipo más común al VPH AR 39 (11,01%) en las participantes del estudio, seguido del VPH AR 31 (8,26%). Se concluye que el inicio de vida sexual temprana y el número de compañeros sexuales fueron factores asociados, pero sin significancia estadística.¹⁰

Montero Trujillo S. presentó en el 2021 su tesis “Asociación entre el rol sexual y la infección por el Virus Del Papiloma Humano en hombres que tienen sexo con hombres de Lima”. El estudio realizó el análisis secundario de datos de un estudio transversal donde se enrolaron hombres que tienen sexo con hombres (HSH) de Lima mediante un muestreo dirigido por el participante. La variable exposición, rol sexual, fue recogida en un cuestionario electrónico. La variable desenlace, número

de genotipos de alto riesgo de VPH, se identificó mediante PCR e hibridación en muestras anales y genitales, se analizaron 200 participantes de 18-59 años. El estudio concluyó que los HSH versátiles fueron el grupo más vulnerable a la infección por VPH genital de alto riesgo y los VIH seropositivos a la infección por VPH anal de alto riesgo.¹¹

Iglesias Osoreo S., Serquén López L., en el 2020 presentaron el artículo “Virus papiloma humano y factores asociados en pacientes con citología desconocida atendidas en el norte de Perú”. El estudio se realizó en pacientes de ginecoobstetricia con citología desconocida atendidas en el Hospital Regional Lambayeque, se realizó PM. En los resultados se encontró que 29,9% tuvieron resultado positivo en la PM, no se encontró diferencia estadística significativa entre la infección por virus del papiloma humano con la edad, edad de primera relación sexual, promiscuidad, número de partos vaginales, lesión de cuello uterino, antecedente de ITS, uso de anticonceptivo hormonal, uso del condón y tabaquismo.¹²

Quispe Alania V. en el año 2020 sustentó su tesis “Relación entre conducta sexual y riesgo de cáncer de cuello uterino en un Hospital de Lima”. Realizó un estudio de tipo cuantitativo, nivel correlacional, retrospectivo y observacional de corte transversal, cuya población de estudio estuvo conformada por 225 mujeres atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, con resultado de biopsia cervical patológico. Los resultados fueron que la conducta sexual y riesgo cáncer cuello uterino, están significativamente relacionados con el riesgo de cáncer cuello uterino.¹³

Medina ML, Medina MG, Merino LA., presentaron en el 2018 el estudio denominado “Principales conductas de riesgo sobre Papilomavirus Humano en universitarios argentinos”. Efectuaron un estudio observacional, descriptivo de corte transversal cuya muestra fue de 61 estudiantes; 77 % mujeres y 23 % hombres. Se observó que 59% tuvieron relaciones sexuales precozmente, (13 años y 27), el 67 % refirió haber tenido dos o más parejas sexuales.¹⁴

Manrique Hinojosa J., Núñez Teran M., Pretel Ydrogo L., Sulcahuaman Allende Y., Roa Meggo Y., Juárez Coello P., Navarro Egúsqiza S. publicaron en el 2018 la investigación titulada “Detección del virus del papiloma humano en muestras obtenidas mediante técnica de autotoma en un grupo de universitarias peruanas”. Este estudio fue de tipo transversal donde se determinó la frecuencia y genotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR) a través de la técnica de autotoma, utilizando el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), cuya muestra estaba constituida por 221 estudiantes. La frecuencia del VPH-AR en las participantes fue de 43,4%; los genotipos encontrados fueron el VPH 16 en el 15,6% y VPH 18 en el 4,2% y otros VPH-AR en el 80,2%¹⁵.

Martínez Peñuela C. realizó en el 2018 la tesis “Prevalencia del virus del papiloma humano en mujeres entre 35 y 65 años con cribado inadecuado de cáncer en cérvix en La Rioja, España. Fue un estudio de tipo descriptivo, con una población muestral de 1000 mujeres sin citología previa durante 3 o más años. El 13% fueron resultados positivos para VPH, según el genotipo de VPH ampliado 76.9% corresponden a VPH-AR, 20.8% para VPH bajo riesgo y 2.3% para VPH de riesgo intermedio. En

cuanto al estudio por genotipos del VPH, el más frecuente fue el VPH 16, seguido por el 33, 6, 45 y 18.¹⁶

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Cuello uterino

El cuello uterino es la parte fibromuscular del útero, que mide de 3 a 4 cm. de longitud y 2,5 cm. de diámetro, cuyas dimensiones podrían variar según la edad, el número de partos y el momento del ciclo menstrual de la mujer. Se encuentra constituido por el exocérnix y el endocérnix. El exocérnix está recubierto por un epitelio escamoso estratificado rosado, de múltiples capas celulares, donde las capas celulares intermedia y superficial contienen glucógeno, mientras que el endocérnix tiene un epitelio cilíndrico rojizo de una única capa celular que lo recubre. La zona de transformación es un área de metaplasia pavimentosa entre la unión escamo-columnar nueva y antigua, ubicada en el orificio cervical externo, este varía según la edad, el momento del ciclo menstrual y otros factores como el embarazo y el uso de anticonceptivos orales, tiene gran importancia en la colposcopia, pues casi todas las manifestaciones de carcinogénesis cervical ocurren en esta zona.¹⁷

2.2.2 Cáncer de cuello uterino

Cuando el material genético contenido en el Ácido Desoxirribonucleico (ADN) de una célula se daña o se altera provocando cambios (mutaciones) irreversibles que afectan el crecimiento y la división normal de las células, generando que las células no mueren cuando deberían morir (apoptosis) y células nuevas se forman cuando el cuerpo no las necesita; estas “nuevas” células pueden o no parecerse a la célula de

la que derivan. Las células que se forman y multiplican de manera acelerada y sin patrón estructural, generan una masa de tejido, que es lo que se llama tumor.¹⁸

El sistema inmunológico debe reconocer, controlar y eliminar una gran cantidad de agentes, internos, externos o ambos, potencialmente nocivos. Uno de ellos es el VPH, que en la mayor parte de los casos se elimina gracias al concurso de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En algunas condiciones no totalmente conocidas, el VPH evade el sistema inmunológico, llevando a infecciones persistentes y a la aparición de neoplasias malignas. La persistencia viral es favorecida por condiciones, como la infección del epitelio estratificado de la piel y las mucosas, donde las células del sistema inmunológico están limitadas en número y diversidad con respecto a otras áreas anatómicas y por la integración del genoma viral en la célula del hospedero, lo que induce cambios en su biología y la transformación maligna.¹⁹

2.2.3 Biología del cáncer de cuello uterino y progresión

El carcinoma cervical surge del epitelio cervical normal a través del desarrollo progresivo de lesiones intraepiteliales cervicales de bajo grado (LIE BG) y lesiones intraepiteliales cervicales de alto grado (LIE AG), donde la infección por VPH-AR desempeña un papel causal importante. La infección por HPV-AR en el epitelio cervical produce alteraciones en el genoma del huésped, lo que lleva al silenciamiento de varios factores supresores de tumores, por un lado, e induce el funcionamiento aberrante de varios factores promotores de tumores, por el otro. El desequilibrio y la inestabilidad causados por diversos factores oncogénicos derivados del VPH-AR en el genoma del huésped de las células epiteliales

cervicales impulsan la progresión neoplásica a lo largo de los años. Sin embargo, la gravedad de los resultados hacia el desarrollo del CCU depende de los genotipos específicos de VPH. En la actualidad se conoce que los genotipos 16 y 18, son los principales promotores de la transformación neoplásica.

Las principales oncoproteínas E5, E6 y E7 codificadas por el genoma del VPH son los principales impulsores de la oncogénesis en el epitelio cervical normal e interrumpen en el funcionamiento normal del complejo principal de histocompatibilidad, que son actores centrales que controlan el crecimiento celular normal, la diferenciación y la función inmune. Se sabe que el aumento de la actividad de la telomerasa está asociado con la inmortalización de las células epiteliales y la oncogénesis. Por lo tanto, los componentes oncogénicos E6 y E7 del genoma del VPH tienen la capacidad de reprogramar el genoma del huésped, el proteoma y la red de señalización intracelular en el nicho epitelial cervical para sostener y promover la oncogénesis viral.²⁰

Se postula que la infección del VPH requiere de la presencia de una microherida, que permite a los viriones infecciosos acceder a la lámina basal. Las células basales infectadas forman el reservorio de la infección y en estas células, el genoma viral se mantiene como un episoma con un número de copias. A medida que estas células se dividen, producen células hijas que son empujadas hacia la superficie epitelial. Se desencadenan diferentes eventos en el ciclo de vida del virus en diferentes etapas durante esta migración. En la zona de transformación cervical y el endocérnix, se cree que el VPH también puede infectar las células epiteliales columnares, las células epiteliales de reserva y las células de la unión escamoso-columnar. La

infección de estos tipos de células puede estar asociada con diferentes patrones de progresión de la enfermedad y con el desarrollo de adenocarcinoma.²¹

2.2.4 Factores de riesgo del cáncer de cuello uterino

El virus del papiloma humano se considera uno de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo del CCU, mientras que la transmisión sexual es la vía predominante de infección por VPH.²²

2.2.4.1 Virus del Papiloma Humano y genotipificación

El VPH forma parte de un grupo de virus denominado comúnmente papilomavirus, pertenecientes a la familia Papillomaviridae, los cuales tienen afinidad por el tejido epitelial.²³ Las partículas del VPH tienen una estructura icosaédrica sin envoltura de 50-60 nm de diámetro, con un genoma compuesto por ADN circular de doble cadena (episomal) de aproximadamente 8000 pb (pares de bases), que contiene ocho o nueve marcos abiertos de lectura.²⁴ Los VPH infectan las células epiteliales y su ciclo de replicación está íntimamente ligado a la diferenciación epitelial. Hay más de 200 genotipos diferentes de VPH identificados hasta la fecha y cada uno muestra una especificidad tisular estricta para la infección.²⁵

El genoma se puede dividir en tres secciones funcionales, la región temprana (E= early) que codifica al menos siete proteínas virales que tienen funciones reguladoras en la célula epitelial infectada (E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8), la tardía (L= late) región que codifica las dos proteínas estructurales virales L1 y L2, que forman la cápside viral, y la LCR (región de control larga), también llamada región reguladora aguas arriba (URR). El LCR contiene secuencias reguladoras de acción que controlan la

replicación y transcripción viral, así como el control postranscripcional a través del LRE (elemento regulador tardío). El genoma está encapsidado en una capa icosaédrica que comprende 360 copias de la proteína L1 organizadas en 72 capsómeros pentaméricos que probablemente tengan una copia de L2 en el centro.²⁴

La clasificación y caracterización de los papilomavirus implican la secuenciación del genoma viral, por lo tanto, se clasifican en genotipos. Los términos "serotipo" y "cepa" no se utilizan para distinguir entre VPH, de hecho, muchos virus del papiloma no se han caracterizado más allá del nivel de su secuencia de ADN.²⁵

Actualmente, se han definido cinco grupos de genotipos evolutivos del VPH: α , β , γ , μ y ν . (11) Cada genotipo difiere del otro en al menos 10% de los genes asociados a una secuencia altamente conservada en una región del gen L1. De estos, el grupo más grande es el grupo α , que contiene cerca de 64 genotipos de VPH que infectan principalmente los epitelios de la mucosa. Aproximadamente 40 de estos pueden infectar el tracto anogenital, incluyendo a los 14 genotipos denominados de alto riesgo "AR" (VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68, 73, 82) que se han clasificado como oncogénicos y se han asociado a diferentes tipos de cáncer anogenital.²⁴

El siguiente grupo más grande son los VPH del grupo β que infectan principalmente los epitelios cutáneos. Se han identificado y caracterizado más de 50 genotipos, pero es probable que existan muchos más, ya que aún continúan siendo aislados

fragmentos de VPH no caracterizados de las lesiones cutáneas. Los tres grupos restantes de VPH (γ , μ y ν) normalmente solo causan enfermedad benigna.²⁴

Los virus capaces de infectar las mucosas se dividen en genotipos de alto y bajo riesgo, en relación a su capacidad oncogénica. Los VPH 6 y 11 producen verrugas benignas en el tracto genital y no son oncogénicos. La infección está caracterizada por lesiones verrugosas. Por otro lado, los VPH-AR están asociados con más del 99% de los cánceres del cérvix. El VPH 16 se encuentra en aproximadamente el 60% de todos los CCU, mientras el VPH 18 está involucrado en un 10-20%; los VPH 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 y 73 juntos constituyen el 20-30% restante de los CCU. El VPH ha sido implicado en el 85% de los casos de cáncer del canal anal, 50% de los cánceres de vulva, vagina y pene, 20% del cáncer orofaríngeo y 10% del cáncer laríngeo y esofágico. A pesar de que la tasa de progresión carcinogénica es relativamente baja, las infecciones por VPH-AR se encuentran en la mayoría de los CCU humanos.²⁶

Los VPH son altamente transmisibles y la mayoría de los hombres y mujeres sexualmente activos adquiere la infección durante su vida. Las infecciones genitales por VPH son transmitidas principalmente por contacto sexual, pero no exclusivamente durante el coito. Mientras las infecciones son en su mayoría transitorias y benignas, la infección genital persistente con ciertos genotipos virales puede conducir al desarrollo de lesiones precancerosas y de cáncer en la región anogenital.²⁶

2.2.4.2 Inicio de una vida sexual a edades tempranas

La infección en edades tempranas hace que el epitelio cervical aún inmaduro, se exponga por un tiempo mayor a la acción transformante del VPH, aumentando el riesgo de desarrollar CCU.²⁶ La zona de transformación es sumamente sensible a la infección viral, con una alta posibilidad de transformarse en anomalías neoplásicas cervicales. En las adolescentes, el epitelio cervical que forma el cuello uterino no se encuentra en su total madurez y la zona de transformación se localiza en el exocérnix, por lo que presenta un mayor grado de exposición a la acción viral.²⁷

Las mujeres son infectadas por alguno de estos virus poco tiempo después del inicio de la vida sexual activa, ocurriendo la mayoría de las infecciones en menores de 25 años. Después de esa edad, la prevalencia disminuye rápidamente. En mujeres de mediana edad, las infecciones por VPH son transitorias, volviendo a observarse un incremento en las infecciones en mujeres de 30 años.²⁸

2.2.4.3 Número de parejas sexuales

El mayor riesgo de adquisición del VPH se relaciona con el inicio temprano de las relaciones sexuales, el elevado número de parejas sexuales a lo largo de la vida, el cambio frecuente de parejas sexual, no uso del condón, el contacto sexual con una persona promiscua, o con varones que tienen contactos con mujeres que ejercen la prostitución.²⁹

Respecto al número de parejas sexuales, se ha demostrado la presencia de HPV, cervical o vulvar en 17-21% de las mujeres con 1 pareja sexual y en 69-83% de aquellas con 5 o más parejas sexuales³⁰.

2.2.4.4 Uso de anticonceptivos hormonales

Las hormonas sexuales son esenciales para la diferenciación y maduración del cuello uterino e influyen en su vulnerabilidad a la infección por VPH. La zona de transformación, en la que se ubica la unión escamocolumnar, es el área anatómica más susceptible a la infección por VPH y al desarrollo de LIE y CCU. La eversión de la zona de transformación, favorecida por ciertas condiciones como el embarazo y el uso de Anticonceptivos Orales Hormonales combinados (AOHC) facilita la exposición de dicho epitelio susceptible al VPH. Además, las mujeres que usan AOHC pueden ser más proclives a no usar preservativo y eso facilita también la infección VPH.³¹

En 2005 la International Agency for Research on Cancer. (IARC) clasificó los AHCO como carcinógenos, la evidencia científica procedía tanto de estudios experimentales como epidemiológicos.³¹

La guía clínica de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare de 2012, reconoce que el riesgo de CCU parece aumentar con la duración del uso de AOHC (> 5 años), pero afirma que los beneficios del uso generalmente supera los riesgos y que este riesgo se equipara al de las no usuarias 10 años después del abandono del método.³¹

2.2.4.5 Tabaquismo

Tabaquismo de largo tiempo de evolución, produce un estado de inmunodepresión local que dificulta el aclaramiento viral. Además, la nicotina y cotinina, y los carcinógenos que contiene el humo del tabaco como los benzopirenos tienen una

acción directa y nociva en el desoxirribonucleico (ADN) celular, estos elementos han sido encontrados en mujeres fumadoras con lesión intraepitelial.³¹

Se considera que las fumadoras tienen doble riesgo de lesión intraepitelial con respecto a las no fumadoras.³²

2.2.4.6 La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Dicha infección se ha considerado como cofactor asociado al riesgo de desarrollar CCU. La inmunodepresión producida por el VIH, y no el virus en sí mismo, es la responsable del incremento de riesgo de progresión. Un reciente análisis muestra que, las pacientes que cumplen correctamente los tratamientos antirretrovirales, reducen el riesgo de adquisición de VPH, así como la incidencia de lesiones intraepiteliales y su progresión.³¹

2.2.4.7 Tratamiento crónico con agentes inmunosupresores

Por la consecuente disminución de la respuesta inmune y la dificultad en permitir el aclaramiento viral.³¹

2.2.4.8 La multiparidad

Se ha sugerido que los niveles elevados de estrógenos y especialmente progesterona durante el embarazo son los responsables de la alteración de la unión escamocolumnar, manteniendo la zona de transformación en el exocérnix muchos años expuesta al VPH y contribuyendo a la persistencia y progresión a lesiones intraepiteliales y cáncer. Otro posible mecanismo es la inmunosupresión ligada al embarazo que podría aumentar el papel del VPH en la carcinogénesis.³¹

2.2.4.9 Cervicitis

La influencia de diferentes agentes infecciosos y su asociación con el VPH en la carcinogénesis cervical no se ha dilucidado por completo. Sin embargo, hay estudios que describen la asociación entre cambios citológicos en el epitelio cervical y la detección de los agentes etiológicos más relevantes de las enfermedades de transmisión sexual. Se cree que la infección por *Chlamydia trachomatis* puede afectar la infección por VPH y su persistencia, ya que la condición supuestamente aumenta las tasas de transformación y progresión de las lesiones precursoras. Dado que la infección es asintomática en la mayoría de los casos, puede pasar sin tratamiento y convertirse así en una infección persistente que favorece la inflamación crónica.³³

2.2.5 Tipos de tamizaje

La implementación de programas de tamizaje con la adopción de métodos mejorados de detección, así como la ampliación en el conocimiento del importante papel del VPH en el desarrollo de la carcinogénesis ha permitido la disminución de la incidencia del cáncer de cuello uterino. El objetivo del tamizaje es detectar las lesiones cervicales tempranas para ser tratadas antes de que se desarrolle el cáncer. En las poblaciones con amplio acceso a los programas de tamizaje, se ha detectado una disminución en la mortalidad por cáncer de cuello uterino del 50-75% en los últimos 50 años.³⁴

La OPS/OMS recomienda tres tipos diferentes de pruebas de tamizaje:

- Citología convencional (Papanicolaou) y en medio líquido (LBC)
- Inspección visual con ácido acético (IVAA)

- Prueba de detección del VPH.³⁵

2.2.5.1 Citología convencional (Papanicolaou) y citología en base líquida (LBC)

El tamizaje mediante citología consiste en la toma de muestras de células de toda la zona de transformación. Las células se fijan en un portaobjetos (frotis de Papanicolaou) o se colocan en un medio líquido para su transporte (CBL) y luego se envían al laboratorio donde citotecnólogos especializados examinan las células con un microscopio. Si el examen microscópico muestra células anormales, se clasifica su grado de anormalidad utilizando el Sistema de Bethesda.³⁶

2.2.5.2 La inspección visual con ácido acético (IVAA)

Es un método que permite detectar cambios tempranos de las células al explorar el cuello uterino a simple vista con el uso del espéculo después de haber aplicado ácido acético diluido (3 al 5%)³⁶, para ser aplicado en el cérvix durante un minuto. Es una metodología que ha surgido recientemente como estrategia de despistaje en países con recursos limitados. Con este procedimiento el epitelio anormal (displásico) se torna blanco y puede ser detectado fácilmente, sin embargo, la sensibilidad del IVAA es variable. En dos metaanálisis recientes se reporta sensibilidades del 70% al 80% para detectar NIC2 y lesiones más severas.³

2.2.5.3 Prueba de detección del VPH (Prueba Molecular de detección de ADN de VPH)

Los métodos moleculares de detección del VPH se basan en la detección de ADN de los tipos de VPH de alto riesgo en muestras vaginales o cervicouterinas. No se recomienda aplicar estos métodos a mujeres menores de 30 años de edad porque muchas jóvenes están infectadas por esos tipos de VPH, pero la mayoría de esas

infecciones remitirán espontáneamente antes de que ellas lleguen a los 30 años de edad.³⁶

2.3 Definición de términos básicos

2.3.1 Inicio de relaciones sexuales

Se denomina relación sexual, al conjunto de procedimientos que efectúan al menos dos seres humanos con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Las relaciones sexuales pueden encerrar diversas prácticas como las caricias sexuales, el sexo oral o el coito.³⁷ Un hecho de la mayor trascendencia en la vida de un individuo lo constituye la primera relación sexual, el uso del propio cuerpo para relacionarse con otros individuos a través del placer es fundamental para su propio desarrollo emocional y para establecer relaciones con sus semejantes en condiciones igualitarias.³⁸

2.3.2 Edad de inicio de relaciones sexuales

Autorreporte de la edad de inicio de la primera relación sexual.

2.3.3 Número de parejas sexuales

Autorreporte del número de parejas sexuales, considerando desde la primera relación sexual hasta la actualidad.

2.3.4 Pruebas moleculares para la detección del Virus del Papiloma Humano (PM-VPH) del Ministerio de Salud.

Pruebas que analizan la presencia de secuencias de ADN viral del VPH, Lo que buscan es detectar infecciones por VPH de alto riesgo persistentes que son las que se asocian con cáncer de cuello uterino.³⁹

2.3.5 Pruebas moleculares para la detección del Virus del Papiloma Humano Negativo.

Resultado negativo al VPH de alto riesgo. En caso el resultado sea negativo se realizará el seguimiento con una nueva prueba molecular cada 5 años.⁴⁰

2.3.6 Pruebas moleculares para la detección del Virus del Papiloma Humano Positivo.

Resultado positivo al VPH de alto riesgo. En mujeres, VPH positivas con colposcopia negativa, se realizará un control al año con una nueva prueba molecular para VPH acompañada de una nueva IVAA.⁴⁰

2.3.7 Genotipos que identifica la Prueba molecular para la detección del VPH de alto riesgo del Ministerio de Salud.

Esta prueba molecular identifica 14 genotipos del VPH de alto riesgo, donde se reporta los genotipos 16, 18 y otros de alto riesgo. En el grupo de otros de alto riesgo tenemos 31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66 y -68.⁴¹

2.3.8 Neoplasia intraepitelial cervical (NIC)

Se refiere a la lectura de una muestra tisular o celular de cuello uterino con afectación del espesor del epitelio y la gravedad de la alteración celular puede ser

NIC 1 si es una displasia leve, NIC 2 si es una displasia moderada y NIC 3 si es una displasia severa y/o carcinoma in situ.³⁹

5CM

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2 CM

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas

H1: Existe asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales en mujeres con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023.

H2: No existe asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales en mujeres con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023

3.2 Variables y definición operacional

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Asociación de: VI1: Edad inicio de relaciones sexuales	Autorreporte de la edad de inicio de la primera relación sexual.	Edad inicio de relaciones sexuales	• Menor de 15 años. • De 15 a 19 años. • De 20 a 24 años. • De 25 a 29 años. • De 30 a más años.	Ordinal
VI2: Número de parejas sexuales	Autorreporte del número de parejas sexuales, considerando desde la primera relación sexual hasta la actualidad.	Número de parejas sexuales	• Única pareja sexual. • De 2 a 4 parejas sexuales • De 5 a 9 parejas sexuales. • De 10 a más.	Ordinal
VD: Mujer con Genotipo de alto riesgo del Virus de Papiloma humano.	Reporte de 14 genotipos del VPH de alto riesgo con potencial oncogénico, donde se reporta los genotipos 16, 18 y otros de alto riesgo. En el grupo de otros de alto riesgo tenemos 31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66 y -68	Posibles resultados de Genotipo de alto riesgo del VPH	• Genotipo 16 • Genotipo 18 • Genotipo otros de alto riesgo (OAR). • Genotipo 16 y OAR. • Genotipo 18 y OAR. • Genotipo 16 y 18 • Genotipo 16, 18, OAR.	Nominal

5CM

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

2 CM

4.1 Diseño metodológico

El diseño es no experimental correlacional, el tipo de investigación es descriptivo, observacional de corte transversal y retrospectivo.

4.2 Diseño muestral

La población que se estudiará, está conformada por 454 pacientes que fueron mujeres con resultado positivo a la Prueba Molecular del VPH-AR en la jurisdicción correspondiente a la Brigada de manejo de lesiones premalignas del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, de la DIRIS Lima Centro, en el período de mayo a diciembre 2023, registradas en el libro de atenciones de la brigada, correspondiente al Servicio de Ginecología. Para el estudio se empleó una muestra de tipo censal, es decir, se tomaron en cuenta todas las pacientes que conforman la población.

Criterios de selección:

Criterios de Inclusión:

- Historias clínicas de pacientes del sexo femenino con resultado positivo a la detección molecular del VPH-AR, atendidas en el período junio a diciembre del 2023.
- Edad del paciente de 30 a 49 años,
- pacientes con datos completos en el libro de registro diario.

Criterios de exclusión:

- Pacientes con resultado negativo en la Prueba Molecular de VPH-AR.
- Edad del paciente menor a 30 años y mayor a 49 años.
- Historias Clínicas con información incompleta.
- Gestantes
- Mujeres con patología oncológica cervical.

4.3 Técnica de recolección de datos

Se recopiló información mediante técnica documental, en una ficha de recolección de información (Anexo 1), desde el libro de registro diario de pacientes atendidas en el consultorio de Ginecología e historia clínica del paciente que acudieron al consultorio de Obstetricia para consejería en Terapia Ablativa en pacientes con VPH-AR positivo.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

En el análisis de los datos se usó estadística descriptiva de frecuencia absolutas y relativas, los resultados serán presentados de forma ordenada en figuras y tablas de una y doble entrada para comparar la asociación del inicio de relaciones sexuales y número de parejas sexuales con el genotipo del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo en mujeres con resultado positivo, atendidas por la brigada de manejo de lesiones premalignas del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, de la DIRIS Lima Centro, en el período de junio a diciembre 2023.

Para ese trabajo se utilizó el software estadístico SPSS versión 24 y Excel 2019, los cuales permitieron realizar el procesamiento y análisis de la información.

4.5 Aspectos éticos

En el trabajo de investigación realizará la revisión de casos de pacientes mujeres con resultado positivo a la Prueba Molecular del VPH-AR en la jurisdicción correspondiente a la Brigada de manejo de lesiones premalignas del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, de la DIRIS Lima Centro, en el período de junio a diciembre 2023. Se recolectará datos registrados en el libro de atenciones de la brigada e historias clínicas de la institución acerca de las características generales y datos relacionados a la ficha de recolección de datos en relación a la investigación, lo que no implica alguna intervención terapéutica que hayan alterado o puesto en peligro la salud de la paciente respetando el principio bioético de no maleficencia y beneficencia al no haber condiciones que causen daño al paciente.

Se mantiene la confidencialidad de los datos teniendo en cuenta el respeto de la autonomía ya que sólo son utilizados para esta investigación.

5CM

CRONOGRAMA

2 CM

PLANIFICACIÓN	MESES 2023																MESES 2024																										
	AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE		
ACTIVIDADES	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Planteamiento del problema	x	x																																									
Formulación del Problema		x	x																																								
Objetivos de la Investigación			x	x	x																																						
Marco teórico: Bases teóricas						x	x	x																																			
Diseño metodológico: Población									x	x	x	x																															
Revisión y aprobación del proyecto													x	x	x																												
Registro de proyecto																x								x	x	x																	
Recolección de datos																																											
Informe Final: Introducción																																											
Diseño metodológico																																											
Resultados																																											
Discusión																																											
Conclusiones y recomendaciones																																											
Sustentación de tesis																																											

5CM

PRESUPUESTO

2 CM

Tipo	Servicio	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Análisis estadístico	1 análisis	800	800.00
	Traducción del documento en inglés	20 hojas	10	200.00
	Subtotal			1000.00
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tóner de impresión, lapicero	Diversos	150	150.00
	Subtotal			150.00
Servicios	Internet	180 hojas	1	180.00
	Impresión y fotocopias de documentos	200 hojas	1	200.00
	Movilidad	5 viajes	20	100.00
	Subtotal			480.00
	Total			1630.00

5CM

BIBLIOGRAFIA

2 CM

1. Mundial de la Salud. Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino. [Internet]. 2020 [citado 6 de agosto de 2023]. Disponible de https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R2-sp.pdf
2. International Agency for Research on Cancer. Cancer today. Número estimado de casos nuevos y mortalidad de cáncer de cáncer en mujeres 2020. [Internet]. Francia: IARC; 2020 [citado 6 de agosto de 2023]. Disponible de <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/604-peru-factsheets.pdf>
3. Ministerio de Salud. Plan Nacional de prevención y control de cáncer de cuello uterino 2017 - 2021. [Internet]. Lima: MINSA; 2016 [citado 2 de agosto de 2023]. Disponible de <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4232.pdf>
4. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Plan Nacional de cuidados integrales del cáncer (2020 - 2024). [Internet]. Lima: MINSA; 2019 [citado 2 de agosto de 2023]. Disponible de <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5341.pdf>
5. Decreto Supremo N° 189-2022-EF. Ley N° 31336: Ley Nacional del Cáncer. [Internet]. Lima: MINSA; 2022 [citado 2 de agosto de 2023]. Disponible de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2974070/Decreto%20Supremo%20N%C2%B0004-2022-SA.pdf>
6. Instituto Nacional de Salud. Detección molecular y genotipificación de virus del papiloma humano como tamizaje de cáncer de cuello uterino: posibilidades en el contexto peruano. Boletín del Instituto Nacional de Salud. [Internet]. Lima: INS; 2016 [citado 7 de agosto de 2023]; 22-24. Disponible de <https://hdl.handle.net/20.500.14196/907>
7. Viñas Sifontes L., Chávez Roque M., Calderón Cruz M. Papiloma virus humani en adolescentes y jóvenes menores de 25 años. [Internet]. Camagüey: Revista Archivo Médico de Camagüey; 2020 [citado 16 de agosto

- de 2023]; 24(3). Disponible de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552020000300007&lng=es
8. Medina ML, Medina MG, Merino LA. Principales conductas de riesgo sobre Papilomavirus Humano en universitarios argentinos. [Internet]. Madrid: Avances de Odontoestomatología; 2018 [citado 23 de agosto de 2023]; 34(6): 311-319. Disponible de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852018000600005&lng=es
 9. Organización Panamericana de la Salud. Cáncer Cervicouterino. [Internet]. 2020 [citado 8 de agosto de 2023]. Disponible de <https://www.paho.org/es/temas/cancer-cervicouterino>
 10. Salazar Torres Z., Heredia Cortez J., Zhingre Suárez A., Cárdenas Heredia F. Virus del papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de Ecuador. [Internet]. 2022. [Citado 26 de octubre de 2023]; 5(15): 671-678. Disponible de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-32432022000300671&lng=es
 11. Montero Trujillo S. Asociación entre el rol sexual y la infección por el Virus Del Papiloma Humano en hombres que tienen sexo con hombres de Lima. [Tesis de maestría en Internet]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2021. [Citado 28 de octubre de 2023]. 87 p. Disponible de https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/10056/Asociacion_MonteroTrujillo_Stephanie.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 12. Iglesias Osoreo S., Serquén López L. Virus papiloma humano y factores asociados en pacientes con citología desconocida atendidas en el norte de Perú. [Internet]. Lima: Revista peruana de ginecología y obstetricia; 2020 [citado 28 setiembre de 2023]; 66(3). Disponible de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322020000300009&lng=es
 13. Quispe Alania V. Relación entre conducta sexual y riesgo de cáncer de cuello uterino en un Hospital de Lima. [Tesis de maestría en Internet]. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal, 2020. [Citado 28 de agosto de

- 2023]. 84 p. Disponible
https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/5165/UNFV_Quispe_Alania_Vilma_Maestria_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14. Medina ML, Medina MG, Merino LA. Principales conductas de riesgo sobre Papilomavirus Humano en universitarios argentinos. [Internet]. Madrid: Revista peruana de ginecología y obstetricia; 2018 [citado 28 agosto de 2023]; 34(6). Disponible de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852018000600005.
 15. Manrique Hinojosa J., Núñez Teran M., Pretel Ydrogo L., Sullcahuaman Allende Y., Roa Meggo Y., Juárez Coello P., Navarro Egúsqiza S. Detección del virus del papiloma humano en muestras obtenidas mediante técnica de autotoma en un grupo de universitarias peruanas. [Internet]. Lima: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica; 2018 [citado 30 agosto de 2023]; 35(4). Disponible de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000400012&lng=es.
 16. Elizalde C., Hernández J., Puente M., Oteo J. Prevalencia del virus del papiloma humano en mujeres entre 35 y 65 años con cribado inadecuado de cáncer en cérvix en La Rioja. [Internet]. La Rioja: Revista de ciencias Zubias. 2018 [citado 1 setiembre de 2023]. Disponible de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6869032>
 17. International Agency for Research on Cancer. La colposcopia y el tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical: Manual para principiantes. [Internet]. 2003 [citado 12 de setiembre de 2023]. Disponible de <https://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=3&chap=1>
 18. De la Garza Salazar J., Juárez Sánchez P. El Cáncer. [Internet]. 2014 [citado 15 de setiembre de 2023]. Disponible de http://eprints.uanl.mx/3465/1/El_Cancer.pdf
 19. Erazo Luna E., Velásquez Lopera M. Respuesta inmunológica al virus del papiloma humano. [Internet]. Antioquia: Revista mexicana de dermatología; 2019 [citado 23 de agosto de 2023]; 63(1): 40-59. Disponible de

<https://dermatologiarevistamexicana.org.mx/article/respuesta-inmunologica-al-virus-del-papiloma-humano/>

20. Olusola P, Banerjee HN, Philley JV, Dasgupta S. Human Papiloma Virus Associated Cervical Cancer and Health Disparities. [Internet]. 2019 [citado 20 de setiembre de 2023]; 8 (6): 622; Disponible de: doi: 10.3390/cells8060622
21. Doorbar, J. Quint W. La biología y el ciclo de vida de los virus del papiloma humano. ELSEVIER [Internet]. 2012 [citado 22 de setiembre de 2023]; 30(5): F55-F70. Disponible de: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.06.083>.
22. Barukčić, I. Virus del papiloma humano: la causa del cáncer de cuello uterino humano. Revista de Biociencias y Medicamentos [Internet]. 2018 [citado 22 de setiembre de 2023]; 6(4): 106-125. Disponible de doi: 10.4236/jbm.2018.64009
23. Santos López G., Márquez Domínguez L., Reyes Leyva J., Vallejo Ruiza V. Aspectos generales de la estructura, la clasificación y la replicación del virus del papiloma humano. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social [Internet]. 2015 [citado 24 de setiembre de 2023]; 56(4): 166-171. Disponible de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2015/ims152h.pdf>
24. Doorbar J, Egawa N, Griffin H, Kranjec C, Murakami I. Biología molecular del virus del papiloma humano y asociación de enfermedades. Rev Med Virol. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social [Internet]. 2015 [citado 15 de setiembre de 2023]; 25(1): 2-23. Disponible de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5024016/>
25. Graham S. El ciclo de replicación del virus del papiloma humano y sus vínculos con la progresión del cáncer: una revisión exhaustiva. National Library of Medicine. [Internet]. 2017 [citado 25 de setiembre de 2023]; 131(17): 2201-2221. Disponible de DOI: 10.1042/CS20160786
26. Viñas Sifontes L., Chávez Roque M., Calderón Cruz M. Papiloma virus humano en adolescentes y jóvenes menores de 25 años. Revista Archivo Médico de Camagüey. [Internet]. 2020 [citado 25 de setiembre de 2023]; 24(7). Disponible de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552020000300007&lng=es
27. Domínguez Bauta S., Trujillo Perdomo T., Aguilar Fabré K., Hernández Menéndez M. Infección por el virus del papiloma humano en adolescentes y

- adultas jóvenes. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología [Internet]. 2018 [citado 25 de setiembre de 2023]; 44(1): 1-13. Disponible de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2018000100017&lng=es
28. Zaldívar Lelo de Larrea G., Martín Molinab F., Sosa Ferreyrac C., Ávila Moralesd J., Lloret Rivase M., Genaro Vega Malagónf G. Cáncer cervicouterino y virus del papiloma humano. Gaceta Mexicana de Oncología. [Internet]. 2011 [citado 25 de setiembre de 2023]; 10(5): 288-294. Disponible de: <https://www.elsevier.es/es-revista-gaceta-mexicana-oncologia-305-articulo-cancer-cervicouterino-virus-del-papiloma-X1665920111894294>
29. Puente Perpiñán M., Haber Reyes M., de los Reyes Losada A., Salas Palacios S. Adolescentes e infección por virus del papiloma humano. MEDISAN [Internet]. 2014 [citado 28 de setiembre de 2023]; 18(6). Disponible de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192014000600004&lng=es
30. Rivera R., Aguilera J., Larraín A. Epidemiología del virus del papiloma humano. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología [Internet]. 2002 [citado 28 de setiembre de 2023]; 67(6): 2201-2221. Disponible de: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262002000600013>.
31. Bosch J.M., Serrano J.R., González. J.V., Lobo P., López Arregui E., Quesada M., Ramón y Cajal J.M., Vanrell C. Guía de Métodos Anticonceptivos, VPH y Lesiones Premalignas de cuello uterino. Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia [Internet]. 2018 [citado 20 de setiembre de 2023]; 44(1): 1-13. Disponible de: https://www.aepcc.org/wp-content/uploads/2019/01/AEPCC_revista09-Anticonceptivos-web.pdf.
32. Villafuerte Reinante J. HGY, ARZ, NHL, GAJJ, BMM. Aspectos bioquímicos y factores de riesgo asociados con el cáncer cervicouterino. Revista Finlay [Internet]. 2019 [citado 23 de setiembre de 2023]; 9(2). Disponible de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342019000200138&lng=es.
33. Wohlmeister D, Renz Barreto VD, Etges Helfer V, Gimenes F, Lopes Consolaro M E, Bones Barcellos. Asociación del virus del papiloma humano y Chlamydia trachomatis con alteraciones intraepiteliales en muestras de cuello

- uterino. Memorias del Instituto Oswaldo Cruz [Internet]. 2016 [citado 25 de setiembre de 2023]; 111(1): 2-23. Disponible de: <https://doi.org/10.1590/0074-02760150330>.
34. Tsikouras P., Zervoudis S. Manav B. , Tomara E., Iatrakis J., Romanidis C., Bothou A., Galacios G. Cáncer de cuello uterino: cribado, diagnóstico y estadificación. J BUON [Internet]. 2016 [citado 25 de octubre de 2023]; 21(2): 320-325. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27273940/>.
35. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Sección 1: Evidencia científica acerca del tamizaje basado en la prueba de VPH [Internet]. PAHO; 2020 [citado 25 de octubre de 2023]. Disponible de: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category__slug=incorporacion-de-la-prueba-del-vph-en-programas-de-prevencion-de-cancercervicouterino&alias=36309-manual-vph-evidencia-cientifica-acerca-tamizajeprimario-basado-prueba-vph-309 .
36. Organización Mundial de la Salud. Control integral del cáncer cervicouterino: Guía de prácticas esenciales [Internet]. OMS; 2014 [citado 25 de octubre de 2023]. Disponible de: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28512/9789275318799_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
37. Saavedra Alvarado C., García Ruiz A., Adonis Hernández Ortiz F. Inicio de la vida sexual y reproductiva en la adolescencia. Revista Estudiantil CEUS. Universidad Estatal Península de Santa Elena [Internet]. 2021 [citado 25 de octubre de 2023]; 3(1): 19-24. Disponible de: <https://ceus.ucacue.edu.ec/index.php/ceus/article/view/51/35>.
38. Welti Chanes C. Inicio de la vida sexual y reproductiva. Universidad Nacional Autónoma de México. [Internet]. 2005 [citado 10 de octubre de 2023]; 11(45). Disponible de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000300007).
39. Ministerio de Salud. Directiva Sanitaria para la prevención de cáncer de cuello uterino mediante la detección temprana y tratamiento de lesiones pre malignas incluyendo carcinoma In Situ [Internet]. MINSA; 2019 [citado 25 de

octubre de 2023]. Disponible de:
<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/07/1005684/rm-576-2019-minsa.pdf>

40. Ministerio de Salud. Guía Técnica: Guía de práctica clínica para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino. [Internet]. MINSA; 2017 [citado 23 de octubre de 2023]. Disponible de:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/342285/Gu%C3%ADa_de_pr%C3%A1ctica_cl%C3%ADnica_para_la_prevencci%C3%B3n_y_manejo_del_c%C3%A1ncer_de_cuello_uterino._Gu%C3%ADa_t%C3%A9cnica20190716-19467-dnxtb7.pdf?v=1563295709
41. Cui M., Chan N., Liu M., Thai K., Malaczynska J., Singh I., Zhang D., Ye F. Clinical Performance of Roche Cobas 4800 HPV Test. Journal of Clinical Microbiology.[Internet]. 2014 [citado 26 de octubre de 2023]; 52(6). Disponible de: <https://journals.asm.org/doi/epub/10.1128/jcm.00883-14>

5CM

ANEXO A

2 CM

TÍTULO: INICIO DE RELACIONES SEXUALES Y NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES ASOCIADO AL GENOTIPO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, DIRIS LIMA CENTRO, 2023

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

N° FICHA

FECHA DE ATENCIÓN:

a. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

a.1 Edad del paciente

- ☐ 1. De 30 a 34
☐ 2. De 35 a 39

- ☐ 3. De 40 a 44
☐ 4. De 45 a 49

a.2 Grado de instrucción

- ☐ 1. Sin estudios
☐ 2. Primaria

- ☐ 3. Secundaria
☐ 4. Estudios Superiores

a.3 Número de gestaciones

- ☐ 1. 0
☐ 2. 1

- ☐ 3. 2 a 3
☐ 4. 4 a más

a.4 Anticonceptivo actual

- ☐ 1. No usa
☐ 2. Inyectable mes
☐ 3. AOC
☐ 4. BTB

- ☐ 5. ISD
☐ 6. Inyectable 3 meses
☐ 7. DIU
☐ 8. Condón

a.5 Hábito de fumar

- ☐ 1. Si

- ☐ 2. No

a.6 Hábito de Consumir alcohol

- ☐ 1. Sí

- ☐ 2. No

b. INICIO DE RELACIONES SEXUALES Y NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES

b.1 Edad de inicio de relaciones sexuales

- ☐ 1. Menor de 15 años
☐ 2. De 15 a 19 años
☐ 3. De 20 a 24 años

- ☐ 4. De 25 a 29 años
☐ 5. De 30 a más años

b.2 Número de parejas sexuales

- ☐ 1. Unica pareja sexual
☐ 2. De 2 a 4 parejas sexuales

- ☐ 3. De 5 a 9 parejas sexuales
☐ 4. De 10 a más

c. GENOTIPO DE VPH-AR

c.1. GENOTIPO

- ☐ 1. Genotipo 16
☐ 2. Genotipo 18
☐ 3. Genotipo Otros de alto riesgo
☐ 4. Genotipo 16 y OAR

- ☐ 5. Genotipo 18 y OAR
☐ 6. Genotipo 16 y 18
☐ 7. Genotipo 16, 18 y OAR

ANEXO B

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Inicio de relaciones sexuales y número de parejas sexuales asociado al genotipo del virus del papiloma humano, DIRIS Lima Centro, 2023

SITUACION PROBLEMÁTICA	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	JUSTIFICACIÓN	HIPÓTESIS	VARIABLES
En el Perú, según Globocan 2020, el número de casos nuevos de cáncer de cuello uterino es de 4270 (11.5%), ocupando el segundo lugar de cáncer en mujeres, provocando 2288 muertes (6.5%), donde cada día, 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de CCU y 6 mujeres fallecen por esta enfermedad. En la actualidad, la población femenina inicia su actividad sexual cada vez más precoz en todo el mundo, siendo los adolescentes, quienes están expuestos a infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas, la infección por el VPH ocupa un lugar significativo, considerándolo como factor fundamental en el desarrollo de CCU. Sin embargo, la sola presencia de la infección viral no es suficiente para que ocurra la transformación maligna, para lo cual se hace necesario la coexistencia del VPH-AR con otros factores, tanto del virus como del hospedero, que contribuyan al desarrollo de este tipo de CCU.	¿Cuál es la asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales en mujeres con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023?	Determinar la asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales en mujeres con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023. Objetivos específicos - Identificar los genotipos del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo presentes en mujeres con resultado positivo. - Identificar las edades de inicio de relaciones sexuales en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo. - Identificar el número de parejas sexuales en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo. - Determinar la asociación entre las edades de inicio de relaciones sexuales y el genotipo identificado en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo. - Determinar la asociación entre el número de parejas sexuales y el genotipo identificado en mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo. - Identificar las edades de las mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo. - Identificar el grado de instrucción de las mujeres con resultado positivo al Virus del Papiloma Humano de alto riesgo.	El tamizaje a través de la Detección Molecular del VPH-AR representa un gran avance en la prevención secundaria en nuestro país. Es por ello que la presente investigación analizará los factores de riesgo de CCU, tales como el inicio de relaciones sexuales y el número de pareja sexuales asociados a la Detección Molecular del VPH-AR en mujeres con resultado positivo, con la finalidad de evidenciar la asociación de ambas variables, con miras de fortalecer las estrategias de tamizaje con la educación sexual, que posibiliten conductas sexuales responsables que conlleven al autocuidado de la salud. En ese sentido, estos resultados permiten sustentar la importancia de la prevención del cáncer de cuello uterino a través de actividades de educación y comunicación, enfocados en los factores de riesgo modificables con miras a fortalecer las estrategias de prevención primaria y secundaria del CCU a nivel nacional. Resaltado la importancia de mejorar la calidad de los servicios de consejería y las actividades extramurales en la comunidad	H1: Existe asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023. H2: No existe asociación entre el inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales en mujeres con el genotipo de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, en la DIRIS Lima Centro, atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en el período de mayo a diciembre 2023	VARIABLE 1: Factores de Riesgo: • Inicio de relaciones sexuales • Número de parejas sexuales VARIABLE 2: Genotipos de alto riesgo del virus de papiloma humano

ANEXO C

VALIDEZ DE INSTRUMENTO



VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN JUICIO DE EXPERTOS TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Inicio de relaciones sexuales y número de parejas sexuales asociado al genotipo del virus del papiloma humano, DIRIS lima centro, junio a diciembre del 2023"

Investigador: Sandra Mariela Chura Borda

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems de la ficha de recolección de datos que contiene casilleros que deberán ser llenados y marcados con un signo , según corresponda a la información recolectada desde la historia clínica por el investigador, decidiendo si cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación.

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde

1.- MUY POCO 2.- POCO O NO ACEPTABLE 3.- REGULAR 4.-ACEPTABLE 5 MUY ACEPTABLE

N°	- ITEMS	PUNTUACION				
		1	2	3	4	5
a.1	Edad del paciente					✓
a.2	Grado de instrucción					✓
a.3	Número de Gestaciones					✓
a.4	Anticoncepción actual				✓	
a.5	Hábito: fumar				✓	
a.6	Hábito: Consumir alcohol				✓	
b.1	Edad de inicio de relaciones sexuales					✓
b.2	Número de parejas sexuales					✓
c.1	Genotipo del Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo					✓

Recomendaciones:

Nombres y apellidos	Yubitz Del Lourdes Pérez Aguilar	DNI:....	41196108
Dirección domiciliaria	Urb. La Arbolada Mc N4 lt2	Teléfono:	952515622
Grado Académico	Magister		
Mención	Magister en Obstetricia		

Firma 
Lugar y Fecha 28 Mayo 2024
Obstetra Especialista
COP 20497 R.N.E. Nº 594 E 05

**VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN JUICIO DE EXPERTOS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

**Inicio de relaciones sexuales y número de parejas sexuales asociado al genotipo del
virus del papiloma humano, DIRIS Ilima centro, junio a diciembre del 2023"**

Investigador: Sandra Mariela Chura Borda

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems de la ficha de recolección de datos que contiene casilleros que deberán ser llenados y marcados con un signo , según corresponda a la información recolectada desde la historia clínica por el investigador, decidiendo al cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación.

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde

1.- MUY POCO 2.- POCO O NO ACEPTABLE 3.- REGULAR 4.-ACEPTABLE 5 MUY ACEPTABLE

N°	- ITEMS	PUNTUACION				
		1	2	3	4	5
a.1	Edad del paciente					X
a.2	Grado de instrucción					X
a.3	Número de Gestaciones					X
a.4	Anticoncepción actual					X
a.5	Hábito: fumar					X
a.6	Hábito: Consumir alcohol					X
b.1	Edad de inicio de relaciones sexuales					X
b.2	Número de parejas sexuales					X
c.1	Genotipo del Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo					X

Recomendaciones:

Nombres y apellidos	LUIS FREDY CHOQUE Mamani	DNI:....	04432960
Dirección domiciliaria	Urb. Monte Verde III C-7 Tacna.	Teléfono:	952-833320
Grado Académico	Doctor	Ocupac.	Docente UNJB.
Mención	Ciencias de la Salud		

Firma
Lugar y Fecha 28.05.2024

DR. LUIS CHOQUE MAMANI
Especialista en Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica
COP. 9038 RNE N° 2536-E.024
Doctor en Ciencias de la Salud

**VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN JUICIO DE EXPERTOS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

**Inicio de relaciones sexuales y número de parejas sexuales asociado al genotipo del
virus del papiloma humano, DIRIS lima centro, junio a diciembre del 2023"**

Investigador: Sandra Mariela Chura Borda

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems de la ficha de recolección de datos que contiene casilleros que deberán ser llenados y marcados con un signo , según corresponda a la información recolectada desde la historia clínica por el investigador, decidiendo si cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación.

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde

1.- MUY POCO 2.- POCO O NO ACEPTABLE 3.- REGULAR 4.-ACEPTABLE 5 MUY ACEPTABLE

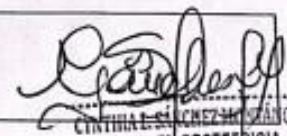
N°	- ITEMS	PUNTUACION				
		1	2	3	4	5
a.1	Edad del paciente					
a.2	Grado de instrucción					✓
a.3	Número de Gestaciones					✓
a.4	Anticoncepción actual					✓
a.5	Hábito: fumar					✓
a.6	Hábito: Consumir alcohol					✓
b.1	Edad de inicio de relaciones sexuales					✓
b.2	Número de parejas sexuales					✓
c.1	Genotipo del Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo					✓

Recomendaciones:

Nombres y apellidos	Cynthia Liset Sánchez Montañez	DNI:....	40201341
Dirección domiciliaria	Urb. Montegoso II etapa Hz. D. Lt. 23	Teléfono:	958015806
Grado Académico	MAESTRA		
Mención	Maestra en Obstetricia		

Firma

Lugar y Fecha 28/05/2024


 CYNTHIA LISSET SÁNCHEZ MONTAÑEZ
 MGR. EN OBSTETRICIA
 C.O.P. 17276